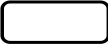
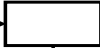


 PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA	Nomor Standar Operasional Prosedur	004/RK.ICU/HK.01.10/RSTK
	Tgl Pembuatan	21 Februari 2022
	Tgl Revisi	17 Februari 2025
	Tgl Pengesahan	21 Februari 2025
	Disahkan Oleh	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja,  Feurah Dihan Bahar NIP. 196805161994012004
	Nama Standar Operasional Prosedur	Alur Penerimaan Pasien Baru Ruang ICU

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang rekam medis 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1778/Menkes/SK/XII/2010 tentang pedoman penyelenggaraan <i>intensive care unit</i> (ICU)	1. Semua tenaga kesehatan yang mempunyai STR dan SIP yang berlaku 2. Semua tenaga kesehatan mampu melayani pasien sesuai bidangnya masing-masing
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SPO Transfer Pasien Antar Ruangan 2. SPO Kriteria Keluar Masuk ICU 3. SPO Tata Tertib Ruang ICU 4. SPO Pemulangan Pasien	1. SIMRS 2. Komputer 3. Alat Kesehatan 4. Alat Kedokteran
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila prosedur penerimaan pasien baru ruang ICU tidak dilaksanakan, akan mengakibatkan terganggu pelayanan di RSUD Tugu Koja	1. Elektronik rekam medis (ERM) 2. Register Pasien ICU

SOP ALUR PENERIMAAN PASIEN BARU RUANG ICU

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Admisi	Perawat ICU	Dokter jaga/ DPJP	Apoteker	Radiografer/ Analis Lab	Kasir	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Petugas Admisi mendaftarkan pasien ICU dari IGD/Rawat Inap/OK yang akan masuk perawatan ICU.							Surat Pengantar Rawat Inap Perina dan SEP (untuk pasien BPJS)	30 menit	Status Rekam Medis Rawat ICU	
2	Perawat ICU menerima pasien dan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan melaporkannya pada dokter jaga/ DPJP.							Alkes, Alked, Komputer E-RM	1-2 jam	Asesmen Awal Masuk Pasien Rawat Inap (E-RM)	
3	Dokter jaga/DPJP melakukan visit dan memberikan instruksi lanjutan (Tindakan, Obat dan Pemeriksaan Penunjang).							Komputer E-RM	30 menit	CPPT, E-Resep, Form Pemeriksaan Lab/Radiologi/ Tindakan	
4	Apoteker memberikan obat sesuai dengan instruksi DPJP/Dokter Jaga.							E-Resep	30 menit	Obat, Alkes dan BMHP	
5	Analis / Radiografer melakukan pengambilan sampel dan pemeriksaan penunjang.							Form Pemeriksaan Lab/Radiologi, Tabung sampel darah, kapas alkohol, spuit	30 menit	Sampel Pemeriksaan Penunjang (Lab/Radiologi)	
6	Perawat ICU melakukan perawatan pasien.							Alkes, Alked, Komputer E-RM, Obat-obatan	tdd	Klinis pasien (membaik/ memburuk)	
7	Petugas Kasir melakukan pengadministrasian pembayaran pasien yang telah selesai perawatan (sembuh/pindah ruang rawat/rujuk RS Luar/meninggal).							Komputer E-RM	15 menit	Perbaikan : Surat Pindah Rawat Sembuh : Surat Kontrol Rujuk : Surat Rujukan Meninggal : Surat Kematian	



Catatan:

- UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh BSSrE BSSN